

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS ONCOLÓGICOS

Validación de alcance con contraparte

Una síntesis para confirmar que comprendimos correctamente el problema, los procesos, las responsabilidades y el resultado esperado antes de continuar el desarrollo.

Propósito de esta reunión

Revisar las propuestas, registrar ajustes y acordar las decisiones necesarias para construir un producto operativo y verificable.

Lo que entendimos

La prioridad no es automatizar decisiones clínicas. Es construir una fuente de verdad operacional, actualizada y gobernada.

Situación actual

- Información distribuida entre PDF, Word, correos y notas.
- Dificultad para confirmar vigencia, estado y responsables.
- Slots, pretests y tareas dependen de coordinación manual.
- Los reportes no comparten todavía definiciones aprobadas.

Resultado del MVP

- Inventario consultable y actualizado.
- Protocolos, cohortes y criterios versionados.
- Gestión trazable de slots, pretesting y tareas.
- Arquitectura modular y APIs documentadas.
- Reportes con fecha de corte y definiciones visibles.

Qué podrá hacer un usuario autorizado

- Buscar estudios por patología, línea, biomarcador, centro y estado.
- Ver qué versión de protocolo está vigente, quién la confirmó y cuándo.
- Distinguir reclutamiento, seguimiento, hold, cierre y archivo.
- Gestionar oportunidades operativas sin emitir elegibilidad.
- Reconstruir cambios relevantes mediante auditoría.

Principio no negociable

La plataforma apoya la organización y la preselección administrativa. La elegibilidad final corresponde siempre al investigador principal y al equipo del estudio.

Las APIs prepararán una interoperabilidad gradual con sistemas autorizados. La conexión con ficha clínica u otras plataformas no forma parte del MVP mientras no exista una definición institucional específica.

Un ciclo de vida compartido

Proponemos separar el estado operativo del estudio de la disponibilidad de cupos o slots.

Preactivación Próximo a abrir; permite anticipar oportunidades.	Activo reclutando Abierto y buscando participantes.	Activo en seguimiento No recluta; mantiene participantes en control.
Hold Reclutamiento detenido temporalmente.	Cerrado Sin actividad operacional vigente.	Archivado Disponible únicamente para historia y trazabilidad.

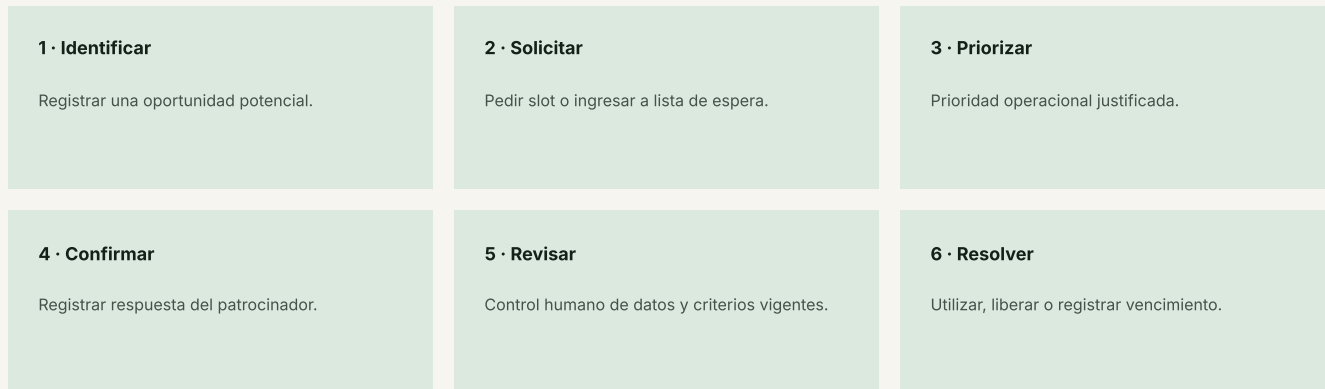
Información mínima propuesta

- Código, nombre y título oficial.
- Patrocinador, fase y diseño.
- Patología, escenario y línea.
- Cohortes, ramas y biomarcadores.
- Centro e investigador responsable.
- Coordinadora responsable.
- Estado operativo y disponibilidad.
- Versión vigente del protocolo.
- Fecha, fuente y responsable de verificación.
- Próxima fecha de revisión.

Necesitamos confirmar

Quién mantiene cada estudio, quién reemplaza a esa persona, cada cuánto se revisa la información y cuándo debe mostrarse como desactualizada.

Flujo propuesto para slots



La lista de espera no constituye un ranking clínico. Todo movimiento debe conservar fecha, fuente, responsable y motivo.

Seguimiento propuesto para pretesting



Usuarios y responsabilidad

- Investigador principal.
- Médico investigador u oncólogo derivador.
- Enfermera coordinadora.
- Jefatura de enfermería.
- Coordinación administrativa.
- Factibilidad y preactivación.
- Administración técnica.
- Auditor autorizado.

Los permisos se definirán por centro, estudio, acción y relación con el recurso. Participar en una reunión o poseer un cargo no concede automáticamente acceso clínico.

Antes de utilizar datos reales

- Aprobar datos mínimos y fundamento o consentimiento aplicable.
- Definir permisos de visualización y modificación.
- Separar información identificatoria, clínica y operativa.
- Definir retención, eliminación y custodia documental.
- Aprobar descargas, exportaciones, auditoría y respuesta ante incidentes.

Fuera del MVP administrativo

Elegibilidad automática, extracción automática de protocolos y recomendaciones clínicas.

Audio en comités, integración con ficha clínica y mensajería externa.

Entorno inicial

Hasta que exista aprobación institucional, el desarrollo, las pruebas y las demostraciones utilizarán únicamente datos ficticios.

Decisiones solicitadas

TEMA	PROPUESTA	VALIDACIÓN
Estados	Preactivación, reclutamiento, seguimiento, hold, cerrado y archivado.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Inventario	Coordinadora responsable, supervisión y fecha de próxima revisión.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Slots	Solicitud, espera, asignación, uso, liberación y vencimiento.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Pretesting	Tareas administrativas con fechas, vigencia y responsables.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Pacientes	Solo datos ficticios hasta aprobar privacidad y permisos.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Elegibilidad	Siempre corresponde al investigador y al equipo clínico.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
IA y voz	Fuera del MVP administrativo inicial.	☐ Aprobar ☐ Ajustar
Reportes	Implementar después de aprobar definiciones de KPI.	☐ Aprobar ☐ Ajustar

Acuerdos y observaciones

Por CICUC

Nombre:

Cargo:

Firma y fecha:

Por el equipo del proyecto

Nombre:

Cargo:

Firma y fecha: